Клинические рекомендации

Грипп у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J09** — Грипп, вызванный определенным идентифицированным вирусом гриппа **J10** — Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа **J11** — Грипп, вирус не идентифицирован
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 20.10.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация "Российское научное медицинское общество терапевтов"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/749_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология и эпидемиология 2

2.3 Классификация 2

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Жалобы и анамнез 4

3.3 Физикальное обследование 4

3.4 Лабораторные исследования 5

3.5 Инструментальные исследования 5

3.6 Консультации специалистов 6

4. Лечение 6

4.1 Противовирусная терапия 6

4.2 Лёгкое и среднетяжёлое неосложнённое течение (амбулаторно) 6

4.3 Осложнённое, тяжёлое и крайне тяжёлое течение (стационар) 8

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 8

5.1 Профилактика 8

5.2 Показания к госпитализации 9

6. Источник и актуальность 9

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 9

1. Основные положения

- Грипп — острая инфекционная болезнь с аэрогенным механизмом передачи, вызываемая вирусами гриппа A, B или C; характеризуется массовым распространением, кратковременной лихорадкой, интоксикацией и поражением респираторного тракта.
- Возбудитель подтверждается экспресс-тестом (иммунохроматография мазка из носоглотки) при обращении **не позднее 2 суток** от появления симптомов или ПЦР мазка из носоглотки; в стационаре ПЦР выполняется всем **в первые сутки** госпитализации. В период эпидемического подъёма диагноз может быть установлен и по клинико-эпидемиологическим данным.
- Противовирусные препараты прямого действия начинают **не позднее 48 часов** (занамивир — **в первые 36 часов**) от манифестации, не дожидаясь лабораторного подтверждения; наилучший эффект — при начале **в первые 12 часов**.
- **Оториноларингологу**
  1. осложнения со стороны ЛОР-органов: синуситы, отиты, тубоотиты, лакунарная и фолликулярная ангина;
  2. при подозрении на бактериальный синусит выполняется рентгенография околоносовых пазух;
  3. при выраженном затруднении носового дыхания — местные адреномиметики **не более 5 дней**.
- **Показания к госпитализации**
  1. тяжёлое и среднетяжёлое течение;
  2. проживание в общежитии, неблагоприятные условия жилой среды;
  3. принадлежность к группе риска неблагоприятного течения.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Грипп (Grippus, Influenza) — острая инфекционная болезнь с аэрогенным механизмом передачи возбудителя, вызываемая вирусами гриппа A, B или C, характеризующаяся массовым распространением, кратковременной лихорадкой, интоксикацией и поражением респираторного тракта.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возбудителями являются РНК-содержащие вирусы семейства ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae), роды A, B, C и D. Основные поверхностные белки — гемагглютинин (H), основной иммуноген, и нейраминидаза (N); мутации нейраминидазы приводят к резистентности к её ингибиторам. Выделяют 18 подтипов гемагглютинина и 11 вариантов нейраминидазы вируса A.

Эпидемиология

1. источник — больной в остром периоде (первые 5–7 дней), в том числе с лёгкой и бессимптомной формой, реже реконвалесцент, выделяющий вирус в среднем 2 недели;
2. механизм передачи аэрогенный (воздушно-капельный и воздушно-пылевой пути), радиус рассеивания 2–3 м; контактно-бытовой имеет значительно меньшее значение;
3. восприимчивость всеобщая; эпидемии в крупных городах длятся в среднем 6–8 недель, пандемии вызываются новыми шифтовыми вариантами вируса.

2.3 Классификация

1. **по течению** — типичное (манифестное), атипичное (бессимптомное, стёртое)
2. **по тяжести** — лёгкая, средняя, тяжёлая, очень тяжёлая (гипертоксическая) степень
3. **по характеру течения** — неосложнённое и осложнённое: специфические (вирус-ассоциированные) осложнения, бактериальные осложнения, обострение или декомпенсация хронических заболеваний

2.4 Клиническая картина

Инкубационный период — **от 1 до 4 дней**, в среднем около 48 часов. Типичный грипп у взрослых начинается внезапно.

Типичные симптомы

1. озноб, лихорадка, прострация;
2. боли в мышцах и суставах, преимущественно нижних конечностей;
3. сильная головная боль, часто со светобоязнью и болезненностью при надавливании на глазные яблоки или при движении ими;
4. вначале лёгкие респираторные симптомы: першение в горле, жжение за грудиной, непродуктивный кашель, иногда насморк;
5. позже — преобладание поражения нижних дыхательных путей, кашель стойкий и продуктивный.

Острые симптомы проходят **через 2–3 дня**, лихорадка может длиться **до 5 дней**; кашель и слабость сохраняются дни и недели.

При неосложнённом гриппе характерны лейкопения с нейтропенией, относительный лимфоцитоз и моноцитоз; СОЭ у большинства нормальная. На рентгенограмме лёгких в остром периоде — усиление сосудистого рисунка.

Критерии оценки тяжести течения гриппа

Признак	Лёгкая	Средняя	Тяжёлая	Очень тяжёлая
Лихорадка	**до 38,5 °C**	**38,6–39,5 °C**	**более 39,6 °C**	**свыше 40,0 °C**
Пульс и систолическое АД	пульс **менее 90** в минуту, САД **110 мм рт. ст. и выше**	пульс **90–120**, САД **менее 110**	пульс **более 120**, нередко аритмичен, САД **менее 90**, тоны сердца глухие	пульс **более 120**, нередко аритмичен, САД **менее 90**, тоны сердца глухие
Частота дыхательных движений	**16–23**	**более 24**	**более 28**	**более 28**
Менингеальный синдром, сознание, судороги	отсутствуют	отсутствуют	менингеальный синдром возможен, оглушение, сопор, возможны судороги и бред	менингеальный синдром часто, сопор, кома, возможны судороги, часто бред и делирий
Длительность заболевания	**до 6 дней**	**6–8 дней**	**9 дней и более**	молниеносное течение

Осложнения гриппа

1. вирусная пневмония, ОРДС, токсический геморрагический отёк лёгких, ложный круп, острая дыхательная недостаточность;
2. инфекционно-токсический шок, инфекционно-токсическая энцефалопатия, отёк головного мозга;
3. неврологические осложнения: менингит, энцефалит, синдром Гийена — Барре, невриты; синдром Рея; миокардит;
4. вторичная бактериальная или вирусно-бактериальная пневмония, септический шок;
5. осложнения со стороны ЛОР-органов: гаймориты, отиты, фронтиты, синуситы, тубоотиты, лакунарная и фолликулярная ангина;
6. декомпенсация хронических заболеваний: бронхиальной астмы, ХОБЛ, хронической сердечной недостаточности, заболеваний печени и почек.

Осложнения возникают у 10–15% больных. Постгриппозные пневмонии развиваются **в конце 1-й — начале 2-й недели** болезни. Частые осложнения гриппа — синуситы и отиты. Тяжёлым осложнением является отёк головного мозга: сильная головная боль, рвота, судороги, нарушение сознания, менингеальный синдром.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. эпидемиологического и клинического анамнеза;
2. клинического осмотра;
3. лабораторных и специальных методов обследования.

При этом определяются клиническая форма и тяжесть болезни, осложнения и показания к терапии. В период эпидемических подъёмов диагноз «грипп» может быть установлен как по лабораторному подтверждению, так и по клиническим и эпидемиологическим данным.

3.2 Жалобы и анамнез

Что уточнить

1. сроки появления лихорадки и интоксикации, ломоту в мышцах и суставах, боль при движении глазных яблок, катаральные явления, боль в грудной клетке;
2. контакт с больным гриппоподобным заболеванием или с подтверждённым гриппом **менее чем за 7 дней** до первых симптомов, эпидемический подъём заболеваемости;
3. приём противовирусных препаратов до обращения;
4. сопутствующие хронические заболевания и беременность.

3.3 Физикальное обследование

При общем осмотре

1. цвет и влажность кожи и видимых слизистых оболочек, инъекция сосудов склер;
2. одышка, мокрота, дистанционные хрипы;
3. положение и поведение пациента;
4. жизненно важные показатели: ЧДД, АД, ЧСС, температура тела.

3.4 Лабораторные исследования

Общий анализ крови и общий анализ мочи выполняются всем пациентам с подозрением на грипп.

1. **неосложнённый грипп** — нормоцитоз или лейкопения, нейтропения, эозинопения, относительный лимфо- и моноцитоз
2. **бактериальные осложнения (пневмония, синусит)** — нарастают лейкоцитоз, палочкоядерный нейтрофилёз, СОЭ
3. **интерстициальное вирусное поражение лёгких** — лейкопения, нейтрофилёз с палочкоядерным сдвигом, анемия, тромбоцитопения

Специфическая диагностика

1. амбулаторно — иммунохроматографический экспресс-тест мазка из носоглотки на антигены вирусов А и В всем, кто обратился **не позднее 2 суток** от появления симптомов;
2. амбулаторно — ПЦР мазка из носоглотки по клинико-эпидемиологическим показаниям: эпидемический очаг, лихорадка **выше 38**, подозрение на поражение нижних дыхательных путей, возраст **старше 65 лет**, хроническая соматическая патология;
3. в стационаре — ПЦР мазка из носоглотки всем пациентам с симптомами ОРВИ **в первые сутки** госпитализации.

Для дифференциальной диагностики выявляют другие возбудители ОРВИ и SARS-CoV-2: экспресс-тестом и ПЦР мазков из носо- и ротоглотки; в стационаре — всем в первый день госпитализации. При подозрении на поражение нижних дыхательных путей исследуют мокроту, аспират из трахеи, жидкость бронхоальвеолярного лаважа.

Серологическое исследование парных сывороток (первая — в день диагноза, вторая — через 2–3 недели) применяется в стационаре для ретроспективной диагностики при невозможности ПЦР; достоверно нарастание титра **в 4 раза и более**.

При тяжёлом и осложнённом течении

1. биохимический анализ крови: билирубин, альбумин, мочевина, креатинин, глюкоза, АСТ, АЛТ, тропонины;
2. кислотно-основное состояние и газы крови — при дыхательной недостаточности;
3. коагулограмма — при геморрагическом синдроме;
4. электролиты крови;
5. маркеры воспаления: фибриноген, прокальцитонин, С-реактивный белок (СРБ).

3.5 Инструментальные исследования

Пульсоксиметрия выполняется всем пациентам на всех этапах помощи; при SpO_2 **менее 90%** исследуют газы артериальной крови и лактат.

Рентгенография или КТ органов грудной клетки показана при явлениях бронхита с физикальными признаками поражения лёгочной ткани; ЭКГ — при осложнённом течении и аускультативных изменениях в сердце.

Рентгенография околоносовых пазух выполняется при катаральных проявлениях в остром периоде или их появлении на фоне терапии, при подозрении на синусит, вызванный присоединением бактериальной флоры.

Спинномозговая пункция с исследованием ликвора проводится при менингеальных симптомах для разграничения менингизма и менингита; при менингизме изменений ликвора нет.

3.6 Консультации специалистов

1. **невролог** — при явлениях менингоэнцефалита
2. **пульмонолог** — при признаках пневмонии
3. **гематолог** — при выраженных гематологических изменениях и геморрагическом синдроме
4. **кардиолог** — при миокардите, острой сердечно-сосудистой недостаточности
5. **акушер-гинеколог** — при гриппе на фоне беременности

Осмотр анестезиолога-реаниматолога для перевода в ОРИТ показан при быстропрогрессирующей острой дыхательной недостаточности: ЧДД **более 25** в минуту, SpO_2 **менее 92%**, а также при другой органной недостаточности (**2 и более балла** по шкале SOFA).

Дифференциальная диагностика проводится с двумя группами инфекций: протекающими с катарально-респираторным синдромом и с ранним развитием лихорадочно-интоксикационного синдрома.

---

4. Лечение

4.1 Противовирусная терапия

Противовирусные препараты прямого действия как препараты первой линии начинают **не позднее 48 часов** (занамивир — **в первые 36 часов**) после манифестации всем пациентам с симптомами гриппа.

1. лечение начинают немедленно, не дожидаясь лабораторного подтверждения;
2. вакцинация и тяжесть болезни на решение не влияют;
3. наилучший эффект достигается при начале **в первые 12 часов**;
4. при отсутствии лечения в ранние сроки препарат может быть начат на любом этапе разгара болезни при предполагаемой репликации вируса.

Амантадин и римантадин для лечения гриппа не рекомендуются: большинство штаммов вируса А к ним резистентны.

4.2 Лёгкое и среднетяжёлое неосложнённое течение (амбулаторно)

Ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир и занамивир. Пациентам вне группы риска с неосложнённым гриппом их назначать не следует.

1. осельтамивир: внутрь по 75 мг 2 раза в сутки, 5 дней; с осторожностью при беременности и грудном вскармливании;
2. занамивир: по 2 ингаляции (по 5 мг) 2 раза в сутки, 5 дней; при резистентности к осельтамивиру, беременным, при тяжёлой почечной недостаточности; не распылять аэрозольным ингалятором.

Балоксавир марбоксил назначается взрослым и детям **старше 12 лет**, в том числе с риском осложнений; прекращает выделение вируса **в течение 1 суток** и активен в отношении штаммов, резистентных к ингибиторам нейраминидазы.

1. масса тела **40–80 кг**: 40 мг внутрь однократно;
2. масса тела **80 кг и более**: 80 мг однократно.

Другие противовирусные препараты прямого действия

1. умифеновир: внутрь до еды по 200 мг 4 раза в сутки, 5 дней; противопоказан в I триместре беременности;
2. риамиловир: внутрь по 250 мг 3 раза в сутки, 5 дней, начать **не позднее 2-го дня** болезни; противопоказан при беременности и грудном вскармливании;
3. энисамия йодид: внутрь по 500 мг 3 раза в сутки, 5–7 дней.

Иммунотропные препараты с опосредованным противовирусным действием (интерфероны, иммуностимуляторы) применяются как препараты второй линии.

1. имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты;
2. ХС221GI;
3. интерферон альфа-2b, интерферон гамма человеческий рекомбинантный интраназально;
4. тилорон;
5. меглюмина акридонацетат;
6. азоксимера бромид;
7. Эргоферон, Рафамин;
8. инозин пранобекс.

При отсутствии эффекта **в течение 24 часов** переходят на противовирусные препараты прямого действия.

1. имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты: 90 мг 1 раз в сутки, 5–7 дней, начать желательно **не позднее 2 суток**; при выраженных симптомах и сопутствующих заболеваниях — 180 мг/сут первые 3 дня;
2. ХС221GI: по 100 мг 2 раза в день, 5 дней;
3. интерферон альфа-2b: интраназально по 3 капли в каждый носовой ход 5–6 раз в день, 5 дней; интерферон гамма: по 2 капли 5 раз в день;
4. тилорон: 125 мг 1 раз в сутки первые 2 дня, затем 125 мг через день (курсовая доза 750 мг);
5. меглюмина акридонацетат: 450–600 мг 1 раз в сутки на 1, 2, 4, 6, 8-е сутки;
6. азоксимера бромид: по 1 таблетке сублингвально 2 раза в день, 7 дней;
7. инозин пранобекс: 6–8 таблеток в сутки в 3–4 приёма.

Всем пациентам показана пероральная дезинтоксикационная терапия: 2–3 литра жидкости в сутки.

При гипертермии **выше 38 °С**, мышечных и суставных болях применяют НПВП или анилиды.

1. ибупрофен: внутрь по 200–400 мг 3–4 раза в сутки, 3–10 дней, не более 1200 мг/сут;
2. парацетамол: по 500–1000 мг до 4 раз в сутки, не более 4000 мг/сут;
3. при выраженных лихорадочно-интоксикационном и респираторном синдромах — комбинации ибупрофен + парацетамол, парацетамол + фенилэфрин + фенирамин.

1. **бронхит с бронхообструкцией и влажным кашлем** — отхаркивающие препараты: ацетилцистеин, бромгексин, амброксол
2. **сухой непродуктивный надсадный кашель** — противокашлевые препараты: бутамират, комбинации с декстрометорфаном

Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых препаратов не рекомендуется: подавление кашлевого рефлекса способствует застою мокроты.

При выраженном затруднении носового дыхания в комплексной терапии ринита и риносинусита применяют местные адреномиметики **не более 5 дней**: они облегчают заложенность носа и восстанавливают проходимость слуховой трубы.

1. ксилометазолин: 0,1% раствор по 2–3 капли или 1 впрыскивание в каждый носовой ход 4 раза в день; противопоказан при беременности;
2. оксиметазолин: 0,025–0,05% раствор по 1–2 капли 2–3 раза в сутки; при беременности и грудном вскармливании — с осторожностью.

4.3 Осложнённое, тяжёлое и крайне тяжёлое течение (стационар)

При поступлении

1. оценить характер поражения органов дыхания и компенсацию сопутствующих болезней;
2. измерить основные физиологические константы;
3. выполнить рентгенографию лёгких и ЭКГ;
4. взять материал для специфической диагностики.

Сразу после поступления начинают осельтамивир, занамивир или балоксавир марбоксил в обычных дозах.

При тяжёлом или прогрессирующем заболевании и тяжёлой иммуносупрессии без ответа на стандартный режим целесообразен #осельтамивир по 150 мг 2 раза в сутки **не менее 10 дней**; с осторожностью при почечной недостаточности.

Меглюмина натрия сукцинат внутривенно капельно применяют при среднетяжёлом и тяжёлом течении и пневмонии для купирования интоксикации: в среднем 10 мл/кг в сутки, курс **до 11 дней**.

При гипоксемии проводится оксигенотерапия: при SpO_2 **менее 92%** — ингаляция кислорода через носовые катетеры или лицевую маску; при острой дыхательной недостаточности — интубация трахеи и ИВЛ, в крайне тяжёлых случаях ОРДС — ЭКМО.

Стрессовые (малые и средние) дозы системных глюкокортикостероидов применяют при рефрактерном септическом шоке и ранней фазе ОРДС — по рекомендациям по неотложным состояниям в ОРИТ.

Антибактериальная терапия проводится при сопутствующей бактериальной инфекции, неэффективности противовирусной и симптоматической терапии, ОРДС и подозрении на вирусно-бактериальную пневмонию — по рекомендациям по внебольничной пневмонии и ОРДС.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Вакцинация проводится всем, не имеющим противопоказаний, в предэпидемический период и заканчивается **за 2–3 недели** до начала эпидемического сезона.

В первую очередь прививают

1. беременных;
2. взрослых **старше 60 лет**;
3. лиц с хроническими заболеваниями, в том числе лёгких и сердечно-сосудистыми, с ожирением;
4. работников медицинских и образовательных организаций.

Экстренную химиопрофилактику ингибиторами нейраминидазы проводят избирательно; если с первого контакта прошло **более 48 часов**, она не рекомендуется. Плановая профилактика осельтамивиром не рекомендуется из-за резистентности. Химиопрофилактика не заменяет вакцинацию.

1. #осельтамивир: по 75 мг 1 раз в сутки **не менее 10 дней** после контакта, начать **в первые 2 дня**;
2. занамивир: 2 ингаляции по 5 мг 1 раз в день, 10 дней;
3. балоксавир марбоксил: однократно **в течение 48 часов** после контакта, 40 мг при массе 40–80 кг, 80 мг при 80 кг и более;
4. умифеновир: по 200 мг в день 10–14 дней после контакта.

При больном в семье

1. изолировать больного в отдельном помещении или за ширмой на расстоянии более 1 м;
2. часто проветривать и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами;
3. кипятить посуду больного, мыть руки после каждого контакта;
4. носить маски со сменой каждые 2 часа.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. тяжёлое и среднетяжёлое течение гриппа;
2. проживание в общежитиях и в условиях неблагоприятных факторов жилой среды;
3. принадлежность к группе риска неблагоприятного течения болезни.

Признаки прогрессирования — схему ведения пересматривают срочно

1. одышка, затруднённое дыхание, синюшность, кровянистая мокрота, боль в груди, гипотония, гипоксия по пульсоксиметру;
2. изменение психического состояния, сонливость, судороги, спутанность сознания, сильная слабость или паралич;
3. устойчивая репликация вируса или вторичная бактериальная инфекция, в том числе высокая температура **более 3 дней**;
4. тяжёлое обезвоживание.

Показания к переводу в ОРИТ (достаточно одного)

1. быстро прогрессирующая острая дыхательная недостаточность, нарастающая одышка, цианоз;
2. ЧДД **более 30** в минуту, SpO_2 **менее 90%**, систолическое АД **менее 90 мм рт. ст.**;
3. шок, дисфункция ЦНС (менее 15 баллов по шкале комы Глазго);
4. острая почечная или печёночная дисфункция, коагулопатия.

Критерии выписки

1. нормализация температуры тела;
2. купирование респираторно-катарального синдрома;
3. нормальные показатели общего анализа крови.

Группы риска тяжёлого течения

1. беременные на любом сроке и в послеродовом периоде;
2. хронические заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы, почек, печени;
3. сахарный диабет, ожирение 2–3 степени;
4. неврологические состояния, гемоглобинопатии;
5. первичные и вторичные иммунодефициты, злокачественные новообразования;
6. возраст **65 лет и старше**.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Грипп у взрослых»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 26.09.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	749_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского; Российское научное медицинское общество терапевтов
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Раздел 3.1.1 рекомендует противовирусные препараты прямого действия «всем пациентам с симптомами гриппа», а комментарий к осельтамивиру и занамивиру указывает, что пациентам вне группы риска с неосложнённым гриппом ингибиторы нейраминидазы назначать не следует.

- Пороги дыхательной недостаточности различаются: для осмотра анестезиолога-реаниматолога (раздел 2.5) — ЧДД более 25 в минуту и SpO_2 менее 92%, для перевода в ОРИТ (приложение А3) — ЧДД более 30 и SpO_2 менее 90%.